

APRESENTAÇÃO

Quem conduz esta conversa

1º Tenente Geraldo

Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco

FORMAÇÃO ACADÊMICA



Engenharia Química — UFPE • Pós-graduação em APH

ATUAÇÃO OPERACIONAL



CBMPE: operações de APH; resgate veicular; piloto de embarcações públicas; incêndio florestal

Especialista em ocorrências com produtos perigosos — CBMBA

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

O copo que quebrou no quintal

- Durante a limpeza do quintal, um copo de vidro se quebra e corta o antebraço de um homem de 40 anos.
- O sangue escorre continuamente e começa a formar poça no chão.
- Ele está pálido e diz que está tonto.



O que fazer agora, na ordem certa?

Fonte: Sinais de sangramento grave: ACS Stop the Bleed, apresentação oficial v. 2.0 (2019) e AHA/Red Cross — 2024 Guidelines for First Aid (Circulation 2024;150:e519–e579). História: simulação editorial.



Reconhecer e acionar antes de tudo



Sangue que escorre continuamente, em grande volume ou em jato: risco de vida.



Poça no chão, roupa encharcada escondendo o ferimento.



Tontura, sonolência, palidez, suor frio: o corpo já está reagindo.



Sua segurança primeiro: só ajude quando for seguro.



Proteja as mãos e acione 192/193 com local, o que aconteceu e o que já foi feito.

192/193: adaptação local declarada (a fonte usa 911)

Sua segurança primeiro



proteger as mãos

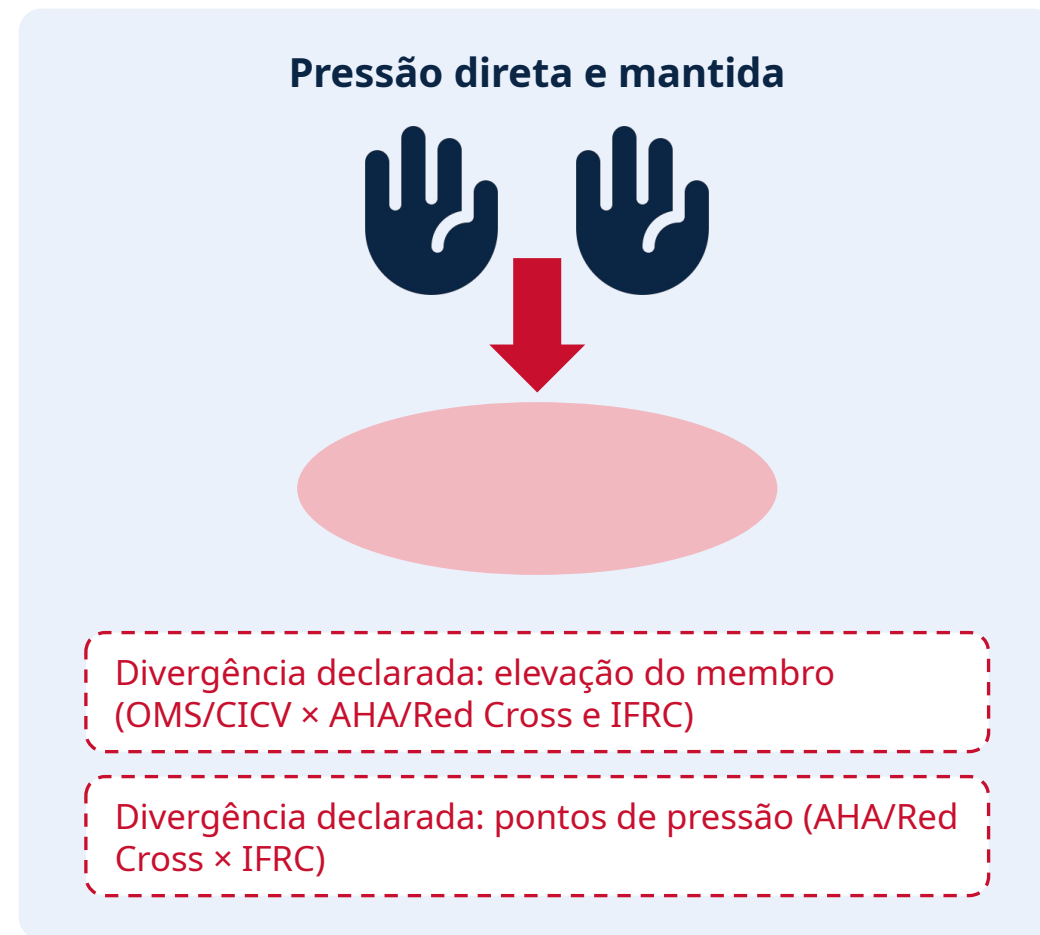


192/193

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

Pressão direta: a primeira medida

-  Aplique pressão manual direta sobre a ferida e mantenha a pressão.
-  Foque no ponto exato de onde sai o sangue.
-  Pano ou gaze só o suficiente para cobrir o ferimento.
-  Ferimento profundo e grande: compactar gaze dentro da ferida até o sangramento ceder.
-  **Não use curativo volumoso: ele espalha a pressão e enfraquece o controle.**



Esquema original • pictogramas Phosphor • não demonstra técnica

Se o curativo encharca, não retire



Não retire



Nunca remova a atadura ou o pano encharcado.



Acrescente e pressione



Acrescente outro curativo por cima do primeiro.



Pressione com mais força e mantenha a pressão.



Motivo: retirar pode desprender o coágulo que já se formou.

Ilustração vetorial original • não demonstra técnica

TORNIQUETE

Torniquete: quando entra

-  Sangramento em braço ou perna que ameaça a vida.
-  Entra quando a pressão direta não resolve ou não pode ser mantida.
-  Primeiro a pressão direta; se o sangramento continuar, então o torniquete.
-  **Aplicado, ele não sai: não afrouxe e não retire.**



Linha de decisão • ilustração vetorial original • não demonstra técnica

TORNIQUETE

Torniquete: como se aplica e o que não se faz depois



Aplicar de 5 a 7,5 cm acima do ferimento — a fonte escreve '2 a 3 polegadas'.



Não posicionar sobre cotovelo ou joelho.



Apertar até o sangramento parar; pode ser aplicado sobre a roupa.



Pode ser aplicado por outra pessoa ou pela própria vítima.



Anotar a hora da aplicação e informar ao serviço de emergência.

Distância acima do ferimento



5 a 7,5 cm



Régua gráfica abstrata • pictogramas Phosphor • não demonstra técnica

Objeto encravado: não se retira

-  **Objeto encravado não se remove — regra única, sem exceção.**
-  Fixar e imobilizar o objeto para que não se mova.
-  A pressão vai ao redor do objeto, nunca sobre ele.
-  Parte amputada: controlar o sangramento, cobrir com curativo seco e não manipular a lesão que não sangra.



Esquema original • pictogramas Phosphor • não demonstra técnica

Couro cabeludo, face e mordedura



Couro cabeludo

Couro cabeludo sangra muito: pressão ao longo das bordas do ferimento.

Se houver afundamento craniano, pressão com cuidado — nunca empurrar fragmento de osso.



Face e pescoço

Face e pescoço têm manejo específico: acionar o serviço de emergência rápido.



Mordedura

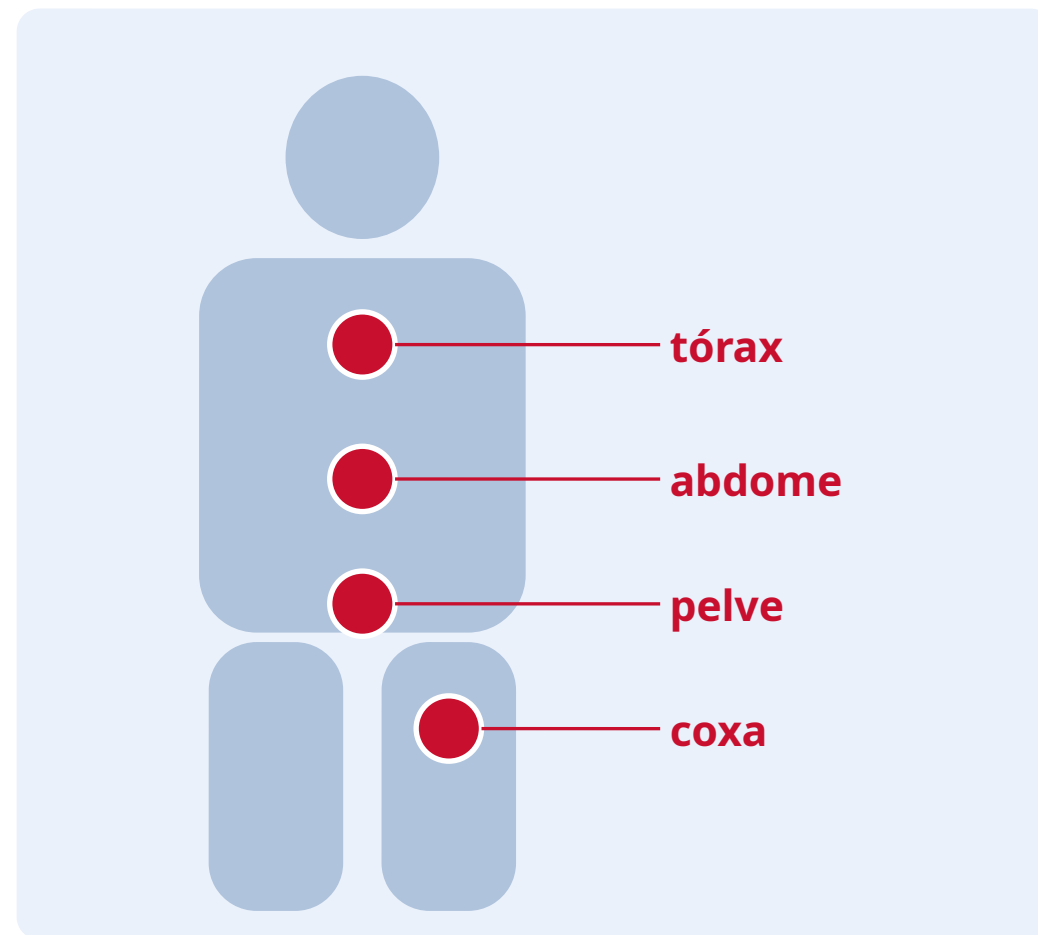
Mordedura: lavar com água limpa o mais rápido possível e tratar como sangramento grave.

Calor ou dor ao redor da ferida depois: procurar atendimento — é sinal de infecção.

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

O sangramento que não se vê

-  Sangue também pode se perder para dentro do tórax, da pelve, da coxa e do abdome.
-  Procure: manchas roxas no umbigo ou nos flancos, sangramento pelo reto, vômito com sangue.
-  Pele fria, úmida e pegajosa, palidez, suor frio, pressão baixa, coração acelerado.
-  **Pressão normal NÃO descarta sangramento grave: em crianças e jovens ela se mantém até a perda de até um quarto do sangue.**



Silhueta abstrata original • não demonstra anatomia

Enquanto o socorro não chega



Mantenha a pessoa em posição confortável.



Mantenha aquecida: roupa ou cobertor.



Observe resposta, respiração e sinais de piora, com a emergência já acionada.



Não ofereça nada para beber nem comer: pode precisar de anestesia e cirurgia.



Se conseguir, a própria pessoa pode pressionar a ferida — reduz contaminação para quem ajuda.



Ilustração: unDraw (licença livre), cores adaptadas • cena de apoio

A chapa de metal na obra

- Numa obra, uma chapa de metal atinge a perna de um trabalhador: corte profundo, sangue escorrendo e poça no chão.
- Um colega aperta o ferimento com um pano; o sangramento diminui, mas continua.
- O pano fica encharcado.



Qual é o próximo passo?

Fonte: AHA/Red Cross — 2024 First Aid; ACS Stop the Bleed v. 2.0 (2019);
Ministério da Saúde / SAMU 192 (2014). Caso simulado.



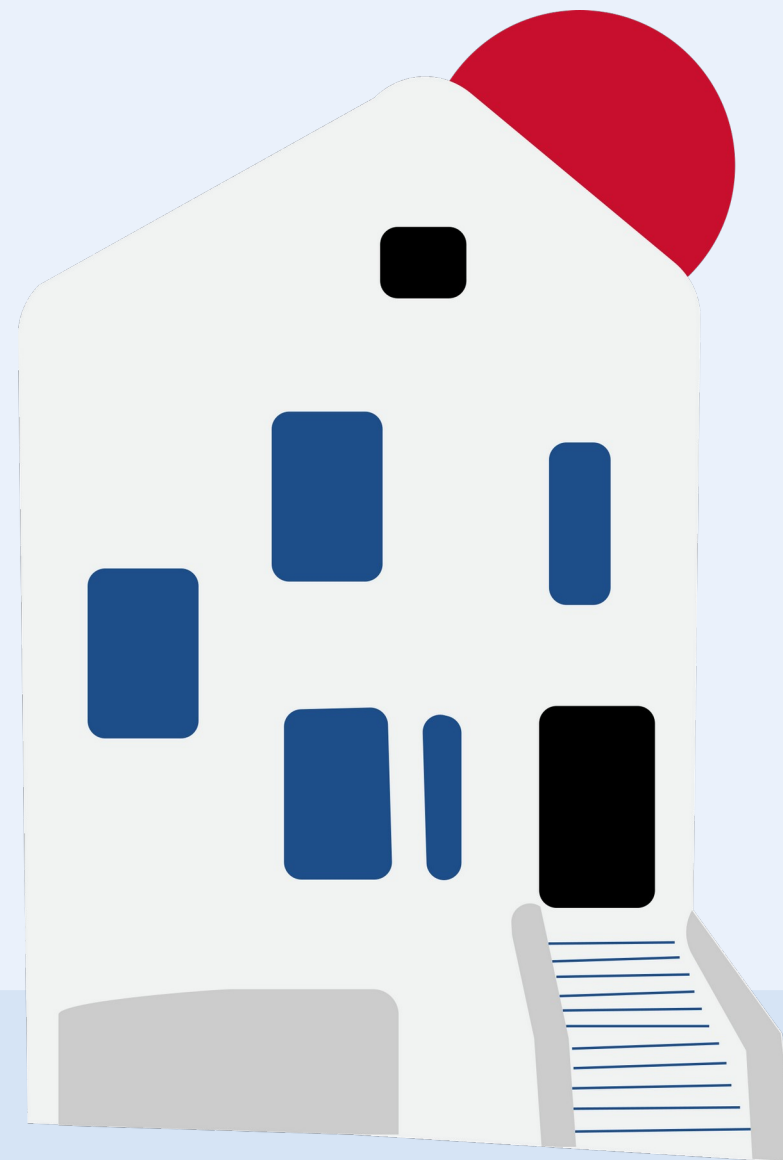
A queda da escada

- Uma mulher de 65 anos cai da escada de casa e bate a cabeça.
- O couro cabeludo sangra muito e o sangue escorre pelo rosto.
- Ela está consciente e conversando, mas tonta.



O que fazer e o que observar?

Fonte: Couro cabeludo: Ministério da Saúde / SAMU 192 — Protocolos de SBP (2014), protocolo BP8; reconhecimento de gravidade: AHA/Red Cross 2024 First Aid. História: simulação editorial.



A mordedura do cão

- Uma criança é mordida no braço pelo cão da casa.
- A ferida é aberta, com sangramento contínuo.
- A família lava o local e cobre com pano limpo.



O que mais precisa ser feito?

Fonte: IFRC — International First Aid, Resuscitation and Education Guidelines 2025; AHA/Red Cross — 2024 First Aid. História: simulação editorial.



Caso da turma: o pano encharcado



Caso: corte profundo na perna, com sangue escorrendo e poça no chão. O pano que pressiona o ferimento fica encharcado.

A

Retirar o pano encharcado para ver o tamanho do corte.

B

Acrescentar outro pano sobre o primeiro e pressionar com mais força.

C

Afrouxar a pressão para o ferido descansar um pouco.

D

Parar tudo e levar de carro, sem chamar o serviço de emergência.

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

RECAPITULANDO

Recapitulando o essencial

-  Segurança pessoal, alertar 192/193, encontrar o sangramento, comprimir.
-  Pressão direta é sempre a primeira medida; tamponamento em ferimento profundo.
-  Torniquete só em sangramento de membro que ameaça a vida e não para com a pressão.
-  **Não retirar curativo encharcado, não remover objeto encravado, não afrouxar torniquete.**
-  **Não usar gelo nem pontos de pressão; não oferecer comida ou bebida a quem pode precisar de cirurgia.**

Segurança → alertar → encontrar → comprimir

1



2



3



4



Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

Questão 1 — Medida inicial



Diante de um sangramento externo grave, qual é a medida inicial recomendada?

A

Aplicar torniquete imediatamente

B

Elevar o membro e esperar

C

Aplicar pressão manual direta sobre o ferimento e mantê-la

D

Colocar gelo sobre a ferida

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

Questão 2 — Próximo passo



Sangramento em uma perna que ameaça a vida e continua apesar da pressão direta e do curativo reforçado. Qual é o próximo passo?

A

Aplicar um torniquete e apertá-lo até o sangramento parar

B

Esperar mais tempo com a mesma pressão

C

Retirar o curativo para localizar o vaso que sangra

D

Lavar a ferida com álcool antes de continuar

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

Questão 3 — Objeto encravado



Um pedaço de vidro está encravado no ferimento que sangra muito. O que se faz?

A

Retirar o vidro com cuidado para estancar o sangramento

B

Puxar o vidro e apertar o local com álcool

C

Remover o vidro apenas se ele pulsar

D

Deixar o objeto no lugar, fixá-lo e aplicar pressão ao redor dele

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

Questão 4 — Sangramento não visível



Queda de moto sem ferimento visível: a pessoa está pálida, com pele fria e úmida e pulso acelerado. Qual é a leitura correta?

A

Sem ferimento visível, não há risco

B

São sinais de má perfusão que podem indicar sangramento não visível, e o serviço de emergência deve ser acionado

C

É apenas nervosismo do acidente, basta acalmar

D

São sinais de infecção e a conduta é observar por 24 horas

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

Questão 5 — Mordedura



Três dias depois de uma mordedura de cão na mão, a ferida está quente e dolorida. O que a orientação indica?

A

Esperar mais uma semana para ver se melhora

B

Passar álcool e cobrir sem procurar atendimento

C

Procurar atendimento de saúde imediatamente, porque calor e dor ao redor da mordedura indicam infecção

D

Só procurar atendimento se aparecer sangramento

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

Gabarito comentado

- 1 – **C** pressão manual direta sobre o ferimento, mantida.
- 2 – **A** torniquete no membro, apertado até o sangramento parar.
- 3 – **D** objeto encravado não se remove — fixar e pressionar ao redor.
- 4 – **B** sinais de má perfusão indicam sangramento não visível; acionar a emergência.
- 5 – **C** calor e dor depois de mordedura indicam infecção; procurar atendimento.



Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

Referências — fontes abertas verificáveis



ACS Stop the Bleed — apresentação oficial do curso v. 2.0 (ACS, 2019).



AHA/Red Cross — 2024 Guidelines for First Aid (Circulation 2024;150:e519–e579).



OMS e CICV — Basic Emergency Care (Genebra, 2018).



Ministério da Saúde / SAMU 192 — Protocolos de Suporte Básico de Vida (Brasília, 2014).



IFRC — International First Aid, Resuscitation and Education Guidelines 2025.

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

Divergências declaradas

DIVERGÊNCIA DECLARADA



Elevação do membro: a OMS/CICV orienta elevar; AHA/Red Cross e IFRC não trazem a elevação.

DIVERGÊNCIA DECLARADA



Pontos de pressão: a AHA/Red Cross considera a utilidade incerta; a IFRC orienta não usar.

DIVERGÊNCIA DECLARADA



Tempo do torniquete: o protocolo brasileiro fala em até duas horas; as fontes internacionais não fixam tempo.

DIVERGÊNCIA DECLARADA



Torniquete improvisado: sem valor em centímetros — a unidade não foi confirmada na fonte.

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

